

ความสามารถคัดกรองสุขภาพตนเองและความพึงพอใจในการใช้แพลตฟอร์ม หมอประจำบ้านของประชาชนในระบบบริการปฐมภูมิ กรุงเทพมหานคร Self-health screening ability and satisfaction with the use of the Doctor at Home platform among people in primary care in Bangkok

วราภา จันทรโชติ * มალიณี จำเนียร* ทศนีย์ ญาณะ** กุลธิดา พงษ์สนธิ *** และชไมพร สุขมาศ***

Warapa Chunchote,* Malinee Jumnian,* Tassanee Yana,** Kullatida Pongsanit,*** and Chamaiporn Sukmas ***

* คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

** มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาาระบบสุขภาพชุมชน

*** ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค กรุงเทพมหานคร

* Faculty of Nursing, Bangkok Thonburi University

** Community Based Health Care Research and Development Foundation

*** Public Health Center 40 Bangkake, Bangkok

บทคัดย่อ

การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความสามารถคัดกรองสุขภาพตนเอง และความพึงพอใจในการใช้แพลตฟอร์มหมอประจำบ้านของประชาชนในระบบบริการปฐมภูมิ กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 370 คน เลือกแบบเจาะจง ประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุข พนักงานช่วยงานศูนย์บริการสาธารณสุข ผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุข พนักงานบริษัทนัยาง จำกัด และนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในพื้นที่เขตบางแค และทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เครื่องมือวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความสามารถคัดกรองสุขภาพตนเอง และความพึงพอใจในการใช้แพลตฟอร์มหมอประจำบ้าน หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคได้เท่ากับ 0.91 และ 0.86 ตามลำดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัย พบว่า ประชาชนมีความสามารถคัดกรองสุขภาพตนเองได้ในระดับมากที่สุด ($M = 3.32, SD = 0.61$) และมีความพึงพอใจในการใช้แพลตฟอร์มหมอประจำบ้านอยู่ในระดับมาก ($M = 2.74, SD = 0.46$)

คำสำคัญ: แพลตฟอร์มหมอประจำบ้าน, ความสามารถคัดกรองสุขภาพตนเอง, ความพึงพอใจ
ระบบบริการปฐมภูมิ

แนวคิดการตรวจคัดกรองสุขภาพ เป็นการค้นหาความผิดปกติของร่างกายในระยะเริ่มต้น ทำให้การรักษาได้ผลดีกว่าพบโรคในระยะลุกลาม ทั้งยังช่วยลดโอกาสการเกิดอาการแทรกซ้อนต่าง ๆ ด้วย (พัทธยา เรียงจันทร์, 2565) ไตรศุลี ไตรสรณกุล (2566) กล่าวถึง การส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาระบบสุขภาพเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางสุขภาพได้มากขึ้น โดยความร่วมมือของหน่วยงานรัฐ ภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ โดย นายแพทย์สุรเกียรติ์ อาชานานุภาพ ได้พัฒนาแพลตฟอร์มหมอประจำบ้าน (Doctor at Home) สำหรับใช้คัดกรองสุขภาพให้ประชาชนนำไปใช้ประโยชน์ได้ จากเนื้อหาตำราการตรวจร่างกายเบื้องต้น และใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial intelligence [AI]) โดยให้ AI ช่วยการประเมินโรคเบื้องต้น ให้ประชาชนใช้ทางออนไลน์ (online) ทั้งเว็บไซต์ (website) และแอปพลิเคชันไลน์ (LINE application) ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลสุขภาพ การตรวจโรค การสอบถามอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นด้วยการใช้สมาร์ทโฟน ทำให้ทราบว่าอาการอย่างไรต้องไปโรงพยาบาล หรือสามารถดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย จะช่วยลดการเดินทางไปพบแพทย์ และลดปัญหาความแออัดในโรงพยาบาลได้ ประชาชนสามารถสมัครใช้บริการผ่านการเพิ่มเพื่อนกับไลน์ @Doctorathome โดยตรง หรือสามารถเพิ่มเพื่อนผ่าน Line Official @nhso ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จากนั้นกดเมนู “Doctor at Home หมอประจำบ้านอัจฉริยะ” สามารถใช้บริการเพื่อประเมินโรคเบื้องต้นได้ทันที นอกจากนี้ Doctor at Home ได้เป็นเครื่องมือสำคัญที่เข้ามาช่วยบุคลากรสาธารณสุข เช่น กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่อาจไม่มีแพทย์ประจำบ้านสามารถใช้แพลตฟอร์ม Doctor at Home เพื่อตรวจสอบประเมินการเจ็บป่วยเพื่อตัดสินใจดำเนินการรักษาที่ถูกต้องและเปิดให้ใช้ แพลตฟอร์มหมอประจำบ้านในเครือข่ายทีมสุขภาพ และประชาชนทั่วไปตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2566

ทางสังคมออนไลน์

อาสาสมัครสาธารณสุข พนักงานช่วยงานศูนย์บริการสาธารณสุข ผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุขประชาชนทั่วไป และนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครในพื้นที่ เขตบางแคและเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ได้เริ่มใช้แพลตฟอร์มหมอประจำบ้านในการคัดกรองสุขภาพตนเอง ในช่วง เดือน กรกฎาคม-พฤศจิกายน 2566 นับเป็นเวลา 5 เดือนแล้ว ยังไม่ได้มีการติดตามประเมินผลของการนำไปใช้ คณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาเรื่องนี้เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนางานในระบบบริการปฐมภูมิ ต่อไป

วัตถุประสงค์การวิจัย

ประเมินความสามารถคัดกรองสุขภาพตนเองและความพึงพอใจต่อการใช้แพลตฟอร์มหมอประจำบ้านของประชาชนในระบบบริการปฐมภูมิ กรุงเทพมหานคร

วิธีดำเนินการวิจัย

ชนิดของการวิจัย เป็น การวิจัยเชิงพรรณนา

ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง

ประชากร เป็นประชาชนในวัยรุ่น วัยทำงาน วัยผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในพื้นที่ เขตบางแคและเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจำนวน 271,481 คน ซึ่งเป็นประชากรเขตทวีวัฒนา จำนวน 79,228 คน และเขตบางแค จำนวน 192,253 คน (กรุงเทพมหานคร กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ, 2565)

กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน เลือกแบบเจาะจงโดยเป็นผู้ที่ได้ใช้แพลตฟอร์มหมอประจำบ้านคัดกรองสุขภาพตนเอง ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขจำนวน 100 คน พนักงานช่วยงานศูนย์บริการสาธารณสุขจำนวน 70 คน ผู้สูงอายุของศูนย์บริการสาธารณสุขจำนวน 40 คน พนักงานบริษัทนัยาง จำกัด จำนวน 80 คน และ นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานครบุรี จำนวน 110 คน

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ใช้ตารางของ Yamane

(1970, อ้างถึงใน ภัทราธิษฐ์ เหมาะทอง และคณะ, ม.ป.ป.) กำหนดระดับความคลาดเคลื่อนที่ร้อยละ 5 ได้กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน

เครื่องมือวิจัย

1. **แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล** จำนวน 5 ข้อ ประกอบด้วย เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา โรคประจำตัว และ เหตุผลที่ตัดสินใจใช้แพลตฟอร์มหมอประจำบ้าน เป็นแบบเลือกตอบ

2. **แบบสอบถามความสามารถคัดกรองสุขภาพตนเอง** จำนวน 9 ข้อ ผู้วิจัยสร้างขึ้น การตอบใช้มาตราประมาณค่า 4 ระดับ ได้แก่ น้อยที่สุด น้อย มาก และมากที่สุด กำหนดคะแนน 1-4 ตามลำดับ การแปลผลระดับใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยดังนี้ 1.00 - 1.75 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 1.76 - 2.50 หมายถึง ระดับน้อย 2.51 - 3.25 หมายถึง ระดับมาก และ 3.26 - 4.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)

3. **แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้แพลตฟอร์มหมอประจำบ้าน** จำนวน 5 ข้อ และคำถามปลายเปิด 2 ข้อ โดยให้แสดงความคิดเห็นเพิ่ม 1 ข้อ และ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 1 ข้อ ผู้วิจัยสร้างขึ้น ครอบคลุมเนื้อหาของความพึงพอใจต่อความสะดวกในการใช้แพลตฟอร์มหมอประจำบ้าน การใช้ภาษาเข้าใจง่าย การลดขั้นตอนในการประเมินสุขภาพตนเอง การลดระยะเวลาในการไปรับบริการทางสุขภาพ และการประหยัดค่าใช้จ่าย การตอบใช้มาตราประมาณค่า 3 ระดับ ได้แก่ น้อย ปานกลาง มาก กำหนดคะแนน 1-3 ตามลำดับ การแปลผลระดับใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ยดังนี้ 1.00 - 1.66 หมายถึง ระดับน้อย 1.67 - 2.33 หมายถึง ระดับปานกลาง และ 2.34 - 3.00 หมายถึง ระดับมาก (วิเชียร เกตุสิงห์, 2538)

คุณภาพของเครื่องมือวิจัย ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (content validity) โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ แพทย์ผู้สร้างแพลตฟอร์มหมอประจำบ้าน แพทย์ผู้ที่เป็นกรรมการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

(สสส) และอาจารย์ สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 1 ท่าน และได้ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และหาความเที่ยงของแบบสอบถามความสามารถคัดกรองสุขภาพตนเอง และความพึงพอใจต่อการใช้แพลตฟอร์มหมอประจำบ้าน โดยนำไปใช้กับกลุ่มที่คล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน หาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ Cronbach ได้เท่ากับ 0.91 และ 0.88 ตามลำดับ

การพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่าง โครงการวิจัยนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เอกสารเลขที่ 23/2566 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ผู้วิจัยชี้แจงการพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่างสามารถยกเลิกการเข้าร่วมโครงการวิจัยได้โดยไม่มีผลกระทบอย่างใด

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2566 ถึง มกราคม 2567 โดยคณะผู้วิจัย จำนวน 5 คน ได้นัดพบกลุ่มตัวอย่างในเขตบางแค และเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร และแจกแบบสอบถามเป็นรายบุคคล ในแต่ละกลุ่ม ดังนี้ 1) อาสาสมัครสาธารณสุข 2) พนักงานช่วยงานศูนย์บริการสาธารณสุข 3) สมาชิกชมรมผู้สูงอายุ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 40 บางแค 4) พนักงานบริษัทนันทยาง ณ บริษัทนันทยาง จำกัด และ 5) นักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ให้เวลาตอบประมาณ 10-20 นาที แล้วรับแบบสอบถามที่มีข้อมูลสมบูรณ์กลับคืนมา จำนวน 370 ชุด คิดเป็น ร้อยละ 92.5

การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป คำนวณสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

1. **ข้อมูลส่วนบุคคล** ประชาชนเป็นเพศหญิง ร้อยละ 81.6 และเพศชาย ร้อยละ 18.4 มีสถานภาพสมรส เป็นโสด ร้อยละ 65.6 รองลงมาคือสมรส ร้อยละ 32.5